

Moduł 2

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Klucz kodowania odpowiedzi:

Kwestionariusz bada nasilenie poszczególnych objawów, czyli sprawdza, czy dane rodzaje zachowań występują częściej niż u dzieci w tym samym wieku, tej samej płci, na tym samym poziomie rozwoju. Występowanie danego zachowania na poziomie typowym dla innych osób tej samej płci, w tym samym wieku i o tym samym miejscu zamieszkania nie jest diagnostyczne i z definicji jest kodowane jako „nie (0)”

- **Nie (0)** – Dany objaw nie występuje lub występuje rzadko. Częstość jego występowania można ocenić jako taką samą jak u innych dzieci tej samej płci, w tym samym wieku i na tym samym poziomie rozwoju. Nie można stwierdzić upośledzenia funkcjonowania dziecka..
- **Chyba nie (1)** – Dany objaw występuje czasami, ale częściej niż u innych dzieci. Objaw tylko sporadycznie wymaga nadzoru ze strony dorosłej osoby. Objaw nieznacznie tylko wpływa na funkcjonowanie dziecka i dla rodziców lub opiekunów jest bardziej zauważalnym zachowaniem niż problemem. Występowanie objawu powoduje jedynie niewielką różnicę w funkcjonowaniu w porównaniu z innymi dziećmi tej samej płci, w tym samym wieku i na tym samym poziomie rozwoju.
- **Raczej tak (2)** – Dany objaw występuje często, czyli przez większość dni w tygodniu. Występowanie objawu powoduje upośledzenie w funkcjonowaniu, powoduje też konieczność okresowego nadzoru ze strony osób dorosłych. Ważne w kodowaniu takiego nasilenia objawu jest występowanie dni czy okresów w ciągu dnia, kiedy dziecko nie potrzebuje nadzoru ze strony osoby dorosłej. Zauważalna jest różnica w funkcjonowaniu dziecka w porównaniu z rówieśnikami tej samej płci, w tym samym wieku i na tym samym poziomie rozwoju.
- **Tak (3)** – Dany objaw występuje codziennie, praktycznie przez cały czas. Konieczny jest nieustanny nadzór osoby dorosłej nad dzieckiem, jednak jego skuteczność jest ograniczona. Występowanie objawu powoduje widoczne i znaczne pogorszenie funkcjonowania dziecka przynajmniej w dwóch środowiskach (np. w domu i w szkole). Bardzo widoczna jest różnica w funkcjonowaniu dziecka w porównaniu z innymi dziećmi tej samej płci, w tym samym wieku i na tym samym poziomie rozwoju.

Nie (0)	= wcale lub rzadko, tak jak u innych dzieci.
Chyba nie (1)	= objaw jest zauważalny, ale nie jest problemem.
Raczej tak (2)	= stanowi problem od czasu do czasu. Są dni lub godziny wolne od objawu.
Tak (3)	= objaw jest problemem <u>cały</u> czas. Dorosli nie zawsze sobie z nim radzą.

Dodatkowe wskazówki do wybranych pytań.

Zaburzenia uwagi, pytanie 1. Proszę zapytać o ilość pomyłek wynikających z zaburzeń uwagi („z niedbalości”). Dla rodzica może to wyglądać jak praca poniżej możliwości dziecka, nieprzykładanie się do wykonywanych zadań, brak starania, usiłowanie by skończyć jak najszybciej. Proszę zapytać o pomyłki w prostych obliczeniach, pomijanie wymaganych szczegółów.

Zaburzenia uwagi, pytanie 2. Proszę zapytać, czy dziecko samo z siebie jest w stanie doprowadzić swoje działania do końca. Czy rozprasza się pomimo braku bodźców z zewnątrz?

Zaburzenia uwagi, pytanie 3. Proszę dodatkowo zapytać, czy polecenia do dziecka muszą być powtarzane wiele razy, (odwlekając wykonanie polecenia musi wynikać z niemożności przerwania wykonywanej czynności – np. zabawy, gry na komputerze – a nie z celowego, opozycyjnego odraczania jego wykonania). Dziecko może mieć problemy z powtórzeniem tego, co zostało powiedziane.

Zaburzenia uwagi, pytanie 4. Konieczne do zakodowania tego objawu jest to, że dziecko przerywa rozpoczętą przez siebie czynność, samo z siebie nie powraca do niej i ostatecznie jej nie kończy. Potrzebna jest pomoc dorosłego albo w dzieleniu zadania na etapy, albo w przywoływaniu dziecka, by kontynuowało swoją pracę.

Zaburzenia uwagi, pytanie 5. Dziecko, wykonując samodzielnie rutynowe czynności: pakowanie tornistra, siadanie do lekcji, ubieranie się, wychodzenie z domu, spędza nad nimi znacznie więcej czasu niż rówieśnicy lub niż wtedy, kiedy interweniuje dorosły. Zasadnicze znaczenie dla kodowania tego objawu ma nieumiejętność zaplanowania przez dziecko tych czynności i / lub wykonanie takiego planu.

Zaburzenia uwagi, pytanie 6. Siadanie do lekcji lub wykonywanie innych czynności wymagających dłuższego wysiłku umysłowego jest problemem. Dziecko wyszukuje kolejne czynności, które musi wykonać zanim usiądzie do lekcji (np. pójście do toalety) lub komentuje konieczność siadania do lekcji albo czynnie odmawia siadania do lekcji. Objaw jest też obecny, jeżeli rodzice nie są w stanie wyegzekwować siadania do lekcji lub zrezygnowali z egzekwowania wykonania przez dziecko prac domowych.

Zaburzenia uwagi, pytanie 7. Dziecko albo gubi różne przedmioty, albo nie potrafi ich znaleźć. Nieustannie szuka swoich rzeczy lub prosi innych, by pomogli mu je znaleźć.

Zaburzenia uwagi, pytanie 8. Dziecko znacznie łatwiej niż rówieśnicy rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych (rozprasza się = przerywa wykonanie zadania i już do niego nie wraca bez interwencji drugiej osoby). Zwłaszcza diagnostyczne jest to, że dziecko rozprasza się pod wpływem bodźców, które większość rówieśników jest w stanie zignorować lub też w ogóle ich nie dostrzega. Diagnostyczne jest też rozpraszanie się pod wpływem własnych myśli.

Zaburzenia uwagi, pytanie 9. Dziecko ma problemy z pamiętaniem o wykonaniu rutynowych codziennych czynności, z którymi radzi sobie większość dzieci w tym samym wieku kalendarzowym i / lub rozwojowym. Przykładem domowych rutynowych czynności są: poranne lub wieczorne mycie się (rozciąganie go w czasie, zapominanie o jego elementach), pamiętanie o domowych zasadach, wykonywanie poleceń wydanych wcześniej (np. kupienie chleba przy powrocie ze szkoły). Przykładem szkolnych czynności rutynowych może być pamiętanie o zapisaniu lub oddaniu pracy domowej, zabranie tornistra lub kurtki z szatni przy wychodzeniu ze szkoły.

Nadruchliwość, pytanie 1. Proszę zwrócić uwagę, czy ruchliwość dziecka zaburza funkcjonowanie innych osób. Przykładowo dziecko, które macha nogami pod ławką i nie przeszkadza tym innym dzieciom w nauce, jest po prostu żywym dzieckiem.

Nadruchliwość, pytanie 2. Proszę zwrócić uwagę czy chodzenie dziecka albo przeszkadzanie innym osobom jest niezgodne z normami kulturowymi (np. chodzenie w czasie nabożeństwa). Jeżeli dziecku wolno chodzić, nie możemy tego kodować jako objawu.

Nadruchliwość, pytanie 3. W przypadku dzieci proszę uwzględnić tylko te sytuacje biegania lub wchodzenia na meble, które rzeczywiście zaburzają funkcjonowanie lub są niebezpieczne (np. wspinanie się po regale z książkami, po barierce od schodów). Konieczne jest odróżnienie ich od zabaw ruchowych – np. skakania po łóżku. Nastolatki i osoby dorosłe powinny być dopytane o uczucie niepokoju lub niemożności usiedzenia w czasie monotonicznych i długich sytuacji.

Nadruchliwość, pytanie 4. W podobnych sytuacjach dziecko jest znacznie głośniejsze (na tyle, że przeszkadza lub zaburza funkcjonowanie innych osób) niż dzieci w tym samym wieku kalendarzowym i / lub rozwojowym.

Nadruchliwość, pytanie 5. Proszę dopytać, czy dziecko odpoczywa w ruchu, a męczy się siedząc spokojnie. Ważne z punktu diagnostycznego jest stwierdzenie, że dziecko, jeśli nie jest niczym zajęte lub gdy się nudzi – to jest w ruchu.

Impulsywność, pytanie 6. Proszę dopytać, czy dziecko próbuje odpowiedzieć na pytanie lub wykonać polecenie, zanim zostanie ono zadane do końca. Ważne jest stwierdzenie, że z powodu zbyt szybkiego działania dziecko nie może albo prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, albo wykonać polecenia, ponieważ nie do końca wie, czego dotyczy pytanie lub polecenie.

Impulsywność, pytanie 7. Proszę zapytać, czy dziecko potrafi poczekać na swoją kolej w sytuacjach grupowych – czekanie w kolejce, stanie w szeregu, korzystanie z atrakcyjnego przedmiotu w określonej kolejności, czekanie na swoją kolej w grze, zgłaszanie się do odpowiedzi i czekanie na wskazanie przez nauczyciela. Proszę dopytać, czy dziecko bardziej niż rówieśnicy nalega na natychmiastowe zwrócenie na nie uwagi.

Impulsywność, pytanie 8. Ważne jest stwierdzenie, że dziecko, włączając się z zewnątrz w aktywność innych osób, zmusza je do przerywania wykonywanej przez nie czynności i do zajęcia się nim (Uwaga: upominanie dziecka jest też koniecznością przerywania wykonywanego zadania). Innym przykładem jest przerywanie zabawy przez grupę dzieci, ponieważ dołączające do nich dziecko próbuje im narzucić swoje pomysły.

Impulsywność, pytanie 9. Dziecko mówi na tyle dużo, że jest to problem dla dorosłego lub innych dzieci. Proszę dopytać się, co to znaczy za dużo – konieczne jest rozróżnienie nadmiernej gadatliwości dziecka od małej tolerancji dorosłej osoby.

Kryterium B. Obecność objawów przed 7 rokiem życia jest konieczna do diagnozy. Wielu rodziców nie szuka pomocy przed siódmym rokiem życia, dlatego konieczne jest zebranie wywiadu retrospektywnie. Część rodziców pamięta trudności w funkcjonowaniu dziecka, część potrzebuje dodatkowych pytań proszących o dokładne opisanie zachowania dziecka np. „proszę powiedzieć, jak dziecko zachowywało się w piaskownicy?” „Jak zachowywało się w przedszkolu?”

Kryterium C. Objawy muszą pojawić się w dwóch środowiskach. Wskazane jest uzyskanie obiektywnego wywiadu z drugiego środowiska, (np. opinia ze szkoły, przejrzanie dzienniczka, wypełnienie kwestionariusza osobno z nauczycielem). Przy wypełnianiu kwestionariusza – przed postawieniem formalnego rozpoznania – dopuszczalne jest oparcie się na subiektywnej relacji rodzica na temat funkcjonowania dziecka w szkole.

Kryterium D. Zachowanie dziecka musi utrudniać jego funkcjonowanie, powodować, że z powodu objawów popada w tarapaty (np. popada w konflikty z dorosłymi i / lub dziećmi). Wskazane jest dopytanie się, w jakich konkretnych sytuacjach widoczne jest gorsze funkcjonowanie dziecka w porównaniu z dziećmi w tym samym wieku i na tym samym poziomie rozwoju.

Kryterium E. Wypełniamy po zebraniu wywiadu rozwojowego od rodziców i przeprowadzeniu badania psychiatrycznego dziecka.

Sposób kodowania – objawy:

Odpowiedzi „nie (0)” oraz „chyba nie (1)” kodujemy jako **brak objawu**

Odpowiedzi „raczej tak (2)” oraz „tak (3)” kodujemy jako **obecność objawu**

Rozpoznanie ADHD według DSM IV TR – proszę wybrać odpowiedni kwadracik:

Zaburzenia uwagi	Nadruchliwość + impulsywność	Rozpoznanie
6 – 9 objawów	0 – 5 objawów	ADHD, podtyp z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi
0 – 5 objawów	6 – 9 objawów	ADHD, podtyp z przewagą nadruchliwości i impulsywności
6 – 9 objawów	6 – 9 objawów	ADHD, podtyp mieszany
0 – 5 objawów	0 – 5 objawów	Brak rozpoznania

Rozpoznanie zespołu hiperkinetycznego według ICD-10

Do postawienia rozpoznania zespołu hiperkinetycznego potrzebne jest stwierdzenie **minimum**:

6 objawów zaburzeń uwagi

3 objawów nadruchliwości

1 objawu nadmiernej impulsywności.

Sposób kodowania punktów objawowych:

Zliczamy wszystkie punkty objawowe, które zaznaczyliśmy w odpowiedziach (tak = 3, raczej tak = 2, chyba nie = 1). Zmiana ilości punktów objawowych może być jednym ze wskaźników nasilania się lub zmniejszania nasilenia danego zaburzenia (np. może służyć do oszacowania poprawy w trakcie leczenia farmakologicznego).

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według ICD-10 i DSM-IV TR

Imię i nazwisko dziecka			
Data badania		Ocenia okres*	
Przyjmowane leki			

* PRZY PIERWSZORAZOWYM BADANIU OCENIAMY WYMAGANY DO ROZPOZNANIA OKRES 6 M-CY, PRZY KOLEJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEBY – „2 M-CE OD OSTATNIEJ WIZYTY”, „1 M-C OD WPROWADZENIA LEKU” MINIMUM CZASU OCENIANEGO TO 2 TYGODNIE.

ZABURZENIA UWAGI

1. Dziecko często nie jest w stanie utrzymać ciągłej i bliższej uwagi na szczegółach lub popełnia błędy z nieuwagi w szkole, pracy lub innej działalności.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

2. Dziecko często nie udaje się utrzymać trwałej uwagi na zadaniach lub grach / zabawach.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

3. Często wydaje się, że dziecko nie słyszy tego, co się do niego / niej mówi.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

4. Dziecko często nie jest w stanie wykonać następujących po sobie instrukcji lub skończyć pracy szkolnej, zadanej pracy lub obowiązków w miejscu pracy (ale nie z powodu przeciwstawiania się (opozycyjnego zachowania) lub niezrozumienia instrukcji).

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

5. Dziecko często ma trudności ze zorganizowaniem sobie pracy lub innych zajęć.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

6. Dziecko nie lubi, ociąga się lub unika zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego – jak nauka szkolna lub odrabianie zajęć domowych.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

7. Dziecko często gubi rzeczy niezbędne do pracy lub innych zajęć, np.: zabawki, przybory szkolne, ołówki, książki, narzędzia.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

8. Dziecko łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

9. Dziecko często jest zapominalskie w trakcie codziennych zajęć.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

Liczba objawów		Liczba punktów objawowych	
----------------	--	---------------------------	--

NADRUCHLIWOŚĆ

1. Dziecko ma często nerwowe ruchy rąk lub stóp bądź nie jest w stanie usiedzieć w miejscu, często macha rękami lub nogami albo wieri się na krzesło.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

2. Dziecko wstaje z miejsca w czasie lekcji lub w innych sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

3. Dziecko często biega wokoło lub wchodzi na meble w sytuacjach, w których jest to nieaprobowane (u nastolatków lub dorosłych może być obecne tylko uczucie niepokoju).

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

4. Dziecko często jest nadmiernie hałaśliwe w zabawie i ma trudności ze spokojnym bawieniem się.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

5. Dziecko często jest w ruchu; „biega jak nakręcone”. Zachowanie dziecka cechuje nadmierna aktywność ruchowa, na którą nie wpływa ani sytuacja, ani potrzeba.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

Liczba objawów		Liczba punktów objawowych	
----------------	--	---------------------------	--

IMPULSYWNOŚĆ

6. Dziecko często wyrwa się z odpowiedzią, zanim pytanie zostanie zadane do końca.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

7. Dziecko często nie udaje się stać w szeregu lub poczekać na swoją kolej w grze lub sytuacji grupowej.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

8. Dziecko często przerywa lub przeszkadza innym (np. wtrąca się do rozmowy lub zabawy innych osób).

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

9. Dziecko często jest nadmiernie gadatliwe.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

Liczba objawów		Liczba punktów objawowych	
----------------	--	---------------------------	--

B. Niektóre upośledzające funkcjonowanie dziecka objawy zaburzeń koncentracji uwagi lub nadpobudliwości psychoruchowej (nadruchliwości, impulsywności) ujawniły się przed 7 rokiem życia dziecka.

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

C. Upośledzenie funkcjonowania dziecka spowodowane tymi objawami występuje w dwóch lub więcej sytuacjach (np. w szkole i w domu).

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

D. Stwierdza się klinicznie istotne upośledzenie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub szkolnego (w zakresie edukacji).

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

E. Objawy u dziecka nie występują w przebiegu przetrwałych zaburzeń rozwojowych, schizofrenii lub innych psychoz i nie można ich trafniej uznać za objawy innego zaburzenia psychicznego (np. zaburzeń nastroju, lękowych, dysocjacyjnych lub nieprawidłowej osobowości).

tak (3) raczej tak (2) chyba nie (1) nie (0)

Rozpoznanie według ICD-10:	
Rozpoznanie według DSM- IV:	